

AERIS | QM-KOMPAKT-HANDBUCH



Notfall-, Hygiene- & Medizintechnik-Checkliste (§ 132I SGB V)

Prüfungsrelevanz für Kassen, Medizinischen Dienst (MD) & Gesundheitsamt: Diese Checkliste dient als vereinfachter, rechtssicherer Qualitätsnachweis für die freiberufliche 1:1-Außerklinische Intensivpflege (AERIS / René Krieg). Sie belegt die kontinuierliche Einhaltung der G-BA AKI-Richtlinie, der RKI-Hygienerichtlinien, der NDS-Expertenstandards sowie der Betreiberpflichten nach MPBetreibV.

1. NOTFALL-MANAGEMENT & KANÜLENKRISEN-PROTOKOLL

Notfallindikation	Symptome / Auslöser	Unverzügliche Erste-Hilfe-Maßnahmen	Pflegerischer QM-Standard
Trachealkanülen-Dislokation (Vollständig / Teilweise)	Plötzliche Atemnot, Desaturation (SpO ₂ < 85%), Beatmungsalarm (P-low/V-low), Stridor.	1. Ruhe bewahren, Notruf/Team verständigen. 2. Dislozierte Kanüle sofort entfernen. 3. Ersatzkanüle (gleiche o. 0,5 kleiner) mit Führungsstab einführen. 4. Fixieren, Beutlung/Respirator rekonnectieren.	Ersatzkanülen (Originalgröße + 1 Nummer kleiner) & Spreizer stets griffbereit am Bett.
Kanülenverstopfung / Sekretbolus	Plötzlicher Druckanstieg (P-high), fehlender Hub, Zyanose, O ₂ -Abfall, Unruhe.	1. Sofortiges tiefes endotracheales Absaugen. 2. Bei Blockade: Innenkanüle sofort wechseln/reinigen. 3. Erfolglos: Sofortiger Notfall-Kanülenwechsel!	Geschlossenes Absaugsystem montiert. Absauggerät netz- & akkubetriebsbereit.
Geräteausfall / Respirator-Störung	Dauer-Alarm, Stromausfall-Anzeige, technische Fehlermeldung, Ausfall Beatmung.	1. Patienten sofort vom Gerät trennen. 2. Manuelle Beutlung mit Beatmungsbeutel + 100% O ₂ . 3. Backup-Respirator einschalten & Konfiguration prüfen.	Beatmungsbeutel mit O ₂ -Reservoir & O ₂ -Flasche (min. 50 bar) direkt am Pflegeplatz.
Respiratorische Dekompensation	BGA-Verschlechterung (pCO ₂ -Anstieg / pO ₂ -Abfall), Tachypnoe, Schweißausbruch.	1. Sekretstatus & Beatmungsdrücke prüfen. 2. Auskultation, BGA-Kontrolle. 3. Notfall-Anpassung nach Arztanordnung / SAPV/Notarzt.	Spezialkompetenz Beatmungstherapeut DGP / BGA-Analyse vor Ort.

Ausrüstungsgegenstand	Soll-Bestand am Pflegeplatz	Prüfintervall	Verantwortlich
Beatmungsbeutel mit PEEP-Ventil & O ₂ -Reservoir	1x betriebsbereit am Bett	Täglich zu Schichtbeginn	Diensthabende AKI-Fachkraft
Ersatz-Trachealkanüle (Original + 1x kleiner)	Je 1x steril verpackt	Täglich (MHD-Check)	Diensthabende AKI-Fachkraft
Sauerstoff-Reserveflasche (medizinischer O ₂)	Mind. 1x 10L Flasche (> 50 bar)	Täglich (Druckkontrolle)	Diensthabende AKI-Fachkraft
Absaugkatheter (verschiedene Ch.-Größen) & NaCl 0,9%	Mind. 20x Katheter / 10x Ampullen	Wöchentlich	AERIS / René Krieg

2. HYGIENE- & INFEKTIONSSCHUTZ-PLAN (RKI-STANDARDS & AKI-RL)

Hygienebereich	RKI / KRINKO Vorgabe	Konkrete Ausführung am Pflegeplatz	Kontrollintervall
Händedesinfektion	5-Momente-Modell der WHO / KRINKO-Empfehlung.	Händedesinfektion vor/nach Klientenkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten (Absaugen, Kanülenpflege) & nach Kontakt mit Infektiösem.	Kontinuierlich / Jede Schicht
Endotracheales Absaugen (VAP-Prophylaxe)	Aseptisches Arbeiten zur Vermeidung beatmungsassoziierter Pneumonien.	Nutzung geschlossener Absaugsysteme oder lokaler Einmal-Mundschutz/Schutzbrille + sterile Einmalkatheter; Anfeuchtung der Atemwege nur bei Indikation.	Bei Bedarf / Mind. alle 2-4 Std.
Tracheostoma- & Wundpflege (ICW®)	Aseptischer Verbandwechsel & Inspektion des Stomas.	Tägliche Inspektion der Stomaumgebung auf Entzündungen; aseptischer Kompressenwechsel (Metalline/Schaumstoff); Reinigung mit Hautantiseptikum.	1x täglich & bei Durchfeuchtung
Flächendesinfektion & Umfeld	Gezielte Wischdesinfektion patientennaher Flächen.	Tägliche Wischdesinfektion von Respirator-Oberfläche, Absauggerät, Pflegebett-Seitenteilen & Doku-Tablet mit VAH-gelisteten Desinfektionstüchern.	Täglich zum Schichtende

3. MEDIZINPRODUKTE- & GERÄTE-COMPLIANCE (MPBETREIBV)

Medizinprodukt	Kategorie (MPG)	Prüfpflicht / Einweisung (MPBetreibV)	Backup & Sicherheitssystem
Haupt-Respirator (Invasiv / Non-Invasiv)	Klasse IIb (Lebenserhaltend)	Einweisungsnachweis im Medizinproduktebuch; STK (Sicherheitstechnische Kontrolle) alle 12 Monate durch Hersteller/Medizintechnik.	Interner Akku (min. 4h) + Externer Zusatzakku + Aktiver Backup-Respirator am Bett.
Backup-Respirator	Klasse IIb (Lebenserhaltend)	Gleicher Konfigurations- & STK-Stand wie Hauptgerät; wöchentlicher Probelauf & Parametersynchronisation.	Einsatzbereit voreingestellt am Stromnetz angeschlossen.
Hustenassistent / CoughAssist	Klasse IIa	Einweisung nach MPBetreibV erfolgt; STK gemäß Herstellerangabe (12–24 Monate).	Manuelle Beutlung / Thoraxkompression als Überbrückung.
Absauggeräte (Haupt- & Mobilgerät)	Klasse IIa	Funktions- & Akkucheck zu jedem Schichtbeginn; STK nach Herstellervorgabe.	Netzunabhängiges Akku-Mobilabsauggerät stets mitgeführt.

Szenario	Automatisierte Reaktion	Handlungsanweisung für die Fachkraft
Lokaler Stromausfall (Netzausfall)	Respirator schaltet nahtlos auf internen Akku; Akustischer Netz-Alarm ertönt.	1. Alarm quittieren & Akkulaufzeit am Display ablesen. 2. Zusatzakku / USV anstecken. 3. Netzbetreiber & Angehörige informieren.
Anhaltender Stromausfall (> 4 Std.)	Akkukapazität nähert sich kritischer Schwelle (< 20%).	1. Notstrom-Aggregat aktivieren / Feuerwehr (Katastrophenschutz) verständigen. 2. Bei Akku-Ertauschung: Manuelle Beutlung vorbereiten.

4. DIGITALE PFLEGEDOKUMENTATION & REVISIONSSCHUTZ (ART. 9 DSGVO & § 630f BGB)

Dokumentations-Modul	Rechtliche / Fachliche Anforderung	Digitale Umsetzung (AERIS Doku-Suite)	Prüfnachweis
SiS® & Maßnahmenplan	Strukturierte Informationssammlung & Risikomatrix (Nationale Expertenstandards).	Digitales Erfassungsformular am Klienten-Tablet vor Ort; tagesaktuelle Anpassung bei Befundänderung.	Gegenzeichnung durch Klient / Vertreter & René Krieg
Schicht-Leistungsnachweis	Lückenlose Dokumentation aller 12h-Dienste & SGB V / SGB XI-Leistungen.	Differenzierte Erfassung von Behandlungspflege (§ 132i) & Grundpflege (§ 36) mit Zeitstempel.	Monatliche Abrechnungsfreigabe & Kasseneinreichung
BGA- & Vitalwertkurve	Medizinische Verlaufsdokumentation für behandelnde Pneumologen / Hausärzte.	Direkte Eingabe von SpO2, EtCO2, Puls, RR, Beatmungsdrücken & BGA-Werten (pH, pCO2, pO2, HCO3).	Export als fälschungssicheres PDF per KIM (Telematik)
Audit-Trail & Datenschutz	Unmanipulierbarkeit der Patientenakte (§ 630f BGB) & Art. 9 DSGVO.	Local-First AES-256 Verschlüsselung auf dem Klienten-Device; kein unverschlüsselter Cloud-Export.	Kryptografischer Zeitstempel nach Schichtabschluss

5. QM-AUDIT-FREIGABE & VERANTWORTLICHKEITEN

Bestätigung der QM-Compliance: Die unterzeichnete Fachkraft garantiert die ständige Einsatzbereitschaft des Notfall-Equipment, die lückenlose Umsetzung des Hygiene- und Infektionsschutzplans sowie die ordnungsgemäße Medizinprodukte-Führung am Pflegestützpunkt des Klienten. Alle Nachweise stehen für Prüfungen durch den Medizinischen Dienst (MD), die Pflegekassen oder das Gesundheitsamt zur Einsichtnahme bereit.

Unternehmensinhaber & Fachkraft: AERIS René Krieg Hohenfelsstraße 34, 35232 Dautphetal	Spezialqualifikationen: • Fachkraft Außerklinische Intensivpflege (AKI) • Beatmungstherapeut (DGP) • Pain Nurse (DGSS) · Wundexperte (ICW®)	Prüf- & Schicht-Status: [] QM-Audit durchgeführt [] Notfallausrüstung vollständig [] Medizintechnik STK-geprüft
_____ Ort, Datum & Unterschrift René Krieg	_____ Unterschrift Klient / Vertreter	_____ Stempel / Visum Prüfbehörde (MD / Kasse)